
Examen blanc de résidanat

Épreuve 2

10 Novembre 2023

Cette épreuve comprends 88 QCM et 17 cas cliniques

I- Partie A : QCM

Veuillez inscrire les réponses aux QCM dans la grille réservée aux QCM

1. Les signes biologiques compatibles avec le diagnostic d'hyperthyroïdie sont :

- A. Une hypocalcémie
- B. Une élévation de la glycémie
- C. Une hypercholestérolémie
- D. Une hyperéosinophilie
- E. Une augmentation minime des transaminases

2. Les complications cardiaques de l'hyperthyroïdie :

- A. Sont fréquentes chez le sujet jeune
- B. Sont favorisées par l'existence d'une cardiopathie antérieure
- C. Peuvent révéler l'hyperthyroïdie
- D. Peuvent se traduire par une insuffisance cardiaque à débit élevé
- E. Sont améliorés par le traitement de l'hyperthyroïdie

3. Les causes médicamenteuses d'hyperthyroïdie sont:

- A. L'amiodarone
- B. La corticothérapie
- C. Le lugol
- D. L'interféron α
- E. L'interleukine 2

4. Les antidiabétiques stimulant la sécrétion d'insuline sont :

- A. Les inhibiteurs du cotransporteur sodium glucose type 2
- B. Les sulfamides
- C. Les biguanides
- D. Les glinides
- E. Les glitazones

5. Les critères déterminants les objectifs glycémiques chez un patient diabétique type 2 comprennent :

- A. L'espérance de vie
- B. L'indice de masse corporelle
- C. Le risque d'hypoglycémie
- D. Le mode de découverte du diabète
- E. Les ressources du patient

6. Les analogues du glucagon like peptide 1 (GLP1) :

- A. Diminuent la libération du glucagon
- B. Accélèrent la vidange gastrique
- C. Augmentent le sentiment de satiété
- D. Favorisent la perte du poids
- E. Sont associés à un risque important d'hypoglycémie

7. Les mécanismes de maladie d'Addison sont:

- A. Un bloc enzymatique surrénalien en 21 hydroxylase
- B. Une auto-immunité surrénalienne
- C. Une auto-médication par des glucocorticoïdes par voie cutanée
- D. Une chirurgie d'adénome surrénalien sécrétant le cortisol
- E. La tuberculose

8. Une insuffisance surrénalienne associée à des surrénales atrophiées peut être observée au cours de :

- A. Métastases surrénaliennes
- B. Apoplexie hypophysaire récente
- C. Tuberculose surrénalienne
- D. Maladie d'Addison
- E. Bloc enzymatique en 21 hydroxylase

9. Patiente âgée de 62 vous montre le bilan biologique suivant: glycémie à jeun 6 mmol/l, Cholestérolémie 5,1 mmol/l et triglycéridémie 14mmol/l. cette patiente présente :

- A. un diabète
- B. une dyslipidémie de type IIa
- C. une dyslipidémie de type IV
- D. une dyslipidémie de type III
- E. un risque de pancréatite aigu à court terme

10. Les triglycérides en excès se déposent dans:

- A. le foie
- B. les paupières
- C. le pancréas
- D. les tendons
- E. les parois vasculaires

11. Une hypothyroïdie avec goitre peut être en rapport avec :

- A- Une carence iodée
- B- Une thyroïdite subaiguë granulomateuse de De Quervain
- C- Une radiothérapie cervicale pour cancer de la sphère ORL
- D- Une thyroïdite chronique lymphocytaire de Hashimoto
- E- Une hypothyroïdie centrale

12. Les médicaments suivants peuvent être responsables d'une hypothyroïdie périphérique :

- A- Le lithium
- B- L'interféron
- C- La cordarone
- D- La digoxine
- E- Le propranolol

13. L'hypothyroïdie peut se compliquer

- A. d'une insuffisance cardiaque
- B. d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire
- C. d'une péricardite
- D. d'une insuffisance coronarienne
- A- d'une hypertension artérielle systolique

14. Le coma myxœdémateux

- A. touche surtout le sujet âgé
- B. Survient surtout en été
- C. Peut-être favorisé par les diurétiques
- D. Est un coma fébrile
- E. Nécessite la prescription de l'hydrocortisone

15. Au cours de l'hyperthyroïdie une absence de fixation isotopique à la scintigraphie thyroïdienne est observée en cas de :

- A- Maladie de Basedow
- B- Adénome toxique
- C- Hyperthyroïdie à l'iode
- D- Thyroïdite subaiguë
- E- Thyrotoxicose factice

16. L'athyréose chez le nourrisson :

- A. entraîne un tableau grave dès la naissance
- B. est la cause la plus fréquente de dysgénésie thyroïdienne
- C. se présente avec des hormones thyroïdiennes indétectables
- D. se présente avec une TSH très élevée
- E. est responsable d'une diminution de la thyroglobuline dans le sang

17. Le retard diagnostic d'une hypothyroïdie chez le nourrisson expose à (aux) risque(s) suivants :

- A. retard mental irréversible
- B. complications cardiovasculaires
- C. avance staturale
- D. un nanisme harmonieux
- E. obésité contrastant avec un retard statural

18. Les dysgénésies thyroïdiennes incluent :

- A. les anomalies du développement thyroïdien
- B. les mutations inactivatrices des récepteurs thyroïdiens
- C. l'absence totale du tissu thyroïdien
- D. les défauts de migration de l'ébauche thyroïdienne
- E. les hypoplasies thyroïdiennes

19. Les signes de déshydratation intracellulaire sont :

- A. La fièvre
- B. Hypotension artérielle
- C. La soif intense
- D. La sècheresse de la langue
- E. Oligurie

20. La réhydratation parentérale est indiquée en cas de :

- A. Vomissements
- B. Déshydratation avec un déficit hydrique >10%.
- C. Hyponatrémie < à 125 meq/L
- D. Troubles de la conscience
- E. Suspicion d'une urgence chirurgicale

21. Les complications immédiates de la déshydratation sont :

- A. L'hyponatrémie
- B. L'état de choc hypovolémique
- C. La thrombose des veines intracrâniennes
- D. Les crises convulsives
- E. L'hématome sous dural

22. Parmi les virus responsables de la bronchiolite on retient :

- A. Le métapneumovirus,
- B. Le coronavirus,
- C. L'entérovirus
- D. Le virus parainfluenzae
- E. Le rotavirus

23. Dans la bronchiolite la radiographie du thorax est indiquée en cas de :

- A. Fièvre à 40 °C
- B. Suspicion de myocardite
- C. Suspicion de trouble de la ventilation
- D. Persistance des symptômes après 5 à 7 jours d'évolution d'une bronchiolite
- E. Hyperleucocytose à prédominance de PNN

24. Les moyens thérapeutiques de la bronchiolite sont :

- A. La désobstruction rhinopharyngée
- B. Le couchage en proclive dorsal à 20°
- C. Un apport hydrique de 120 à 150 ml/kg/jour
- D. Traitement antipyrétique en cas de fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$
- E. Oxygénothérapie si la $\text{SpO}_2 < 94\%$

25. Une immunité passive est conférée par :

- A. Le vaccin ROR administré en sous-cutané
- B. Transfert transplacentaire d'anticorps maternels
- C. Immunoglobulines contre l'hépatite B
- D. Primo-infection par le virus de la rougeole
- E. Le vaccin ROR administré en IM

26. Le vaccin pneumococcique polysaccharidique simple chez l'enfant :

- A. Couvre 13 sérotypes
- B. Couvre 23 sérotypes
- C. Est très efficace pour prévenir les infections à pneumocoque
- D. Est efficace quel que soit l'âge de l'enfant
- E. L'efficacité vaccinale est d'environ 5 ans

27. Dans le cadre d'une méningite, la corticothérapie

- A. Doit être débutée avant toute antibiothérapie
- B. Est à base de dexaméthasone 10mgx4/j pendant 10 jours
- C. Permet de diminuer le risque de surdité
- D. Est indiquée en cas de méningite à pneumocoque
- E. Est contre indiquée en cas de méningite tuberculeuse

28. Les facteurs favorisant la méningite à *listeria* sont

- A. Ethylisme
- B. Diabète
- C. Infection à VIH
- D. Grossesse
- E. Age avancé

29. En cas de méningite aiguë, les éléments de mauvais pronostic sont

- A. Hyperprotéinorachie > 1,5g/l
- B. Le retard d'un traitement adapté
- C. L'âge > 60 ans
- D. L'agitation
- E. Les ROT vifs

30. La méningite bactérienne récurrente chez l'enfant peut être favorisée par un(e):

- A. Infection à adénovirus
- B. Brèche ostéo-méningée
- C. Déficit en complément
- D. Infection VIH
- E. Splénectomie

31. Les bactéries responsables de méningite chez le Nouveau-né sont :

- A. *Staphylocoque aureus*
- B. *Streptococcus pneumoniae* (Pneumocoque)
- C. *Escherichia coli* K1
- D. *Haemophilus influenzae*
- E. *Streptococcus agalactiae* (Streptocoque B)

32. Les indications de la cystographie rétrograde (UCR) dans l'infection urinaire de l'enfant sont :

- A. Les anomalies à l'échographie rénale
- B. l'infection urinaire à *Klebsiella pneumoniae* sécréteur de bêta lactamase à spectre étendu (BLSE)
- C. L'Infection urinaire à *Proteus*
- D. L'âge inférieur à 3 mois
- E. Le deuxième épisode d'infection urinaire

33. Les molécules suivantes peuvent être utilisées dans le traitement d'une urétrite à gonocoque:

- A. Métronidazole
- B. Ceftriaxone
- C. Cefotaxime
- D. Azithromycine
- E. Vancomycine

34. *Chlamydia trachomatis* peut être responsable des manifestations suivantes :

- A. Une kérato-conjonctivite chez le nouveau-né
- B. Une urétrite antérieure aigue
- C. Une vulvovaginite
- D. Une cervicite
- E. Une balanite

35. Le portage persistant des infections à gonocoque est dû à la localisation suivante

- A. Urétrale
- B. Prostatique
- C. Anorectale
- D. Cervicale
- E. Pharyngée

36. Le diagnostic d'une infection à *Trichomonas vaginalis* est évoqué devant :

- A. Des leucorrhées purulentes associée à une cervicite
- B. Des leucorrhées claires
- C. La présence de piqueté hémorragique au niveau vulvovaginal
- D. L'association fréquente d'une vulvovaginite à une cervicite
- E. La présence de prurit vulvaire et de dyspareunie

37. En cas d'AES par une source connue infectée par le VIH, et en l'absence de prophylaxie chez la personne exposée, le suivi virologique repose sur :

- A. Test rapide VIH
- B. Charge virale à J20
- C. Taux des CD4
- D. Western Blot VIH
- E. ELISA à J0, M1, M3 et M6

38. Les antigènes microbiens «Patogen Associated Molecular Patterns »:

- A. Constituent des éléments susceptibles de freiner le système immunitaire
- B. sont des lipopolysaccharides pour les bactéries à Gram négatif
- C. sont des peptidoglycanes pour les bactéries à Gram positif
- D. sont des acides mycosiques pour les mycobactéries
- E. sont glycolipides pour les spirochètes

39. Les objectifs à atteindre lors de la prise en charge d'un choc septique sont :

- A- Une pression artérielle systolique 100 mmhg
- B- une Pression artérielle moyenne ≥ 65
- C- Un débit urinaire $\geq 0,5$ ml/kg/h
- D- Une SvO₂ $< 60\%$
- E- Une amélioration de la clairance des lactates

40. Les facteurs qui peuvent baisser la SVO2 sont :

- A. L'augmentation du débit cardiaque
- B. L'hypoxémie
- C. L'augmentation de l'hématocrite
- D. La baisse de l'EO2
- E. L'anémie

41. Dans le cadre des fractures ouvertes de la jambe, Une plaie contuse et isolée de la jambe peut correspondre à

- A. Une fracture ouverte de la jambe type I de Cauchoix et Duparc.
- B. Une fracture ouverte de la jambe type II de Cauchoix et Duparc.
- C. Une fracture ouverte de la jambe type III de Cauchoix et Duparc.
- D. Une plaie à risque de nécrose secondaire des berges.
- E. une fracture fermée si elle suturée sous tension

42. Lors de l'état végétatif :

- A – l'état de conscience est minimal
- B – les réflexes cornéens et photomoteurs sont en général conservés
- C - Il existe une réaction appropriée aux stimulations douloureuses
- D – Toutes les fonctions végétatives sont conservées
- E – le patient présente un des aspects évolutifs des comas

43. Lors de l'examen des réflexes d'un patient en coma :

- A- Le réflexe oculo-cardiaque se manifeste par une bradycardie persistante après compression des globes oculaires.
- B- L'abolition unilatérale des réflexes ostéotendineux est un signe de localisation.
- C- la recherche d'une réponse de décortication fait partie des réflexes du tronc.
- D- Le réflexe oculo-cardiaque est le dernier à disparaître avant la mort cérébrale.
- E- Le réflexe photomoteur se manifeste par une contraction pupillaire par la stimulation douloureuse.

44. Lors de l'examen clinique d'un patient comateux :

- A- La résistance à l'ouverture des yeux est en faveur d'une aréactivité psychogène.
- B- la vigilance est évaluée par l'ouverture des yeux.
- C- La recherche des réflexes du tronc cérébral précède la prise en charge symptomatique.
- D- la conservation des mouvements des yeux oriente vers le Locked-in syndrome.
- E- L'évaluation du score du Glasgow est nécessaire après la sédation.

45. Le diagnostic positif d'un état de mort encéphalique est posé devant :

- A. Une angiographie cérébrale montrant l'absence de circulation cérébrale des 4 axes vasculaires
- B. L'absence d'activité électrique sur l'électroencéphalogramme pendant 30 mn chez un patient non sédaté stable sur le plan hémodynamique normo tendu
- C. L'absence de ventilation spontanée sous benzodiazépine
- D. un coma profond aréactif avec une mydriase bilatérale aréactive
- E. La disparition des réflexes du tronc cérébral à une température en dessous de 28°

46. Le Facteur rhumatoïde au cours de la polyarthrite rhumatoïde :

- A. Est de e classe IgM
- B. Est mis en évidence dans le sérum par la Réaction de Waaler Rose
- C. Est très spécifique de la polyarthrite rhumatoïde
- D. A une moins bonne sensibilité que les anti-CCP
- E. Peut rester négatif dans 20% des cas

47. La polyarthrite rhumatoïde :

- A. Peut-être précocement destructrice
- B. Les anti- CCP sont très spécifiques mais peu sensibles
- C. Peut se compliquer d'une sacro-iliite
- D. Peut être responsable d'une luxation atloïdo-axoïdienne
- E. Il existe une augmentation de la mortalité principalement cardiovasculaire

48. La polyarthrite rhumatoïde ne touche généralement pas:

- A. Le rachis cervical
- B. Les épaules
- C. Les articulations coxo fémorales
- D. Le rachis dorsal
- E. Les sacro-iliaques

49. Le bilan biologique de la polyarthrite rhumatoïde peut monter :

- A- une CRP élevée
- B- la présence du facteur rhumatoïde
- C- une hyperuricémie
- D- une hypercalcémie
- E- la présence des anticorps anti CCP (Anti peptide citrulliné)

50. Indiquer les anomalies radiologiques rencontrées dans une main rhumatoïde :

- A- Ostéophytes
- B- calcification cartilagineuse
- C- pincement articulaire
- D- érosions et géodes osseuses
- E- déminéralisation en bande

51. Lorsqu'un arrêt cardiaque se prolonge

- A. L'administration de bicarbonates par voie intraveineuse est systématique.
- B. L'adrénaline est administrée à dose de 1 mg chaque 3-5 minutes.
- C. Le massage cardiaque interne doit être discuté.
- D. La décision d'arrêt des manœuvres de réanimation doit être discutée au-delà de 30 minutes de réanimation cardio-pulmonaire.
- E. Un traitement par dobutamine peut être proposé pour potentialiser l'effet de l'adrénaline.

52. Le(s) mécanisme(s) le(s) plus fréquent(s) à l'origine d'un arrêt cardio-respiratoire chez un jeune adulte est (sont) :

- A. L'asystolie.
- B. La torsade de pointes.
- C. La fibrillation ventriculaire.
- D. Tachycardie ventriculaire sans pouls.
- E. La fibrillation auriculaire.

53. Les traitements pharmacologiques recommandés au cours de la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée sont :

- A. La noradrénaline.
- B. L'adrénaline.
- C. L'atropine.
- D. La lidocaïne.
- E. L'amiodarone.

54. On vous appelle pour un patient inconscient qui respire difficilement avec absence de pouls. Lesquelles des interventions suivantes devez-vous effectuer ?

- A. Une ventilation toutes les 10 secondes pendant 2 minutes.
- B. Effectuer des cycles de tapes dans le dos et des poussées thoraciques.
- C. Des compressions thoraciques et des ventilations pendant 2 minutes à un rythme 15/2.
- D. Des compressions thoraciques sans ventilations.
- E. Alerter puis faire à la fois des compressions thoraciques et des ventilations à un rythme 30/2.

55. Dans le choc cardiogénique :

- A. Le débit cardiaque est augmenté.
- B. Les résistances vasculaires systémiques sont augmentées.
- C. La pression télédiastolique du ventricule droit est augmentée.
- D. La pression veineuse centrale est toujours diminuée
- E. La pression artérielle moyenne peut-être normale

56. Les éléments en faveur d'un choc cardiogénique primaire secondaire à un infarctus de myocarde sont :

- A. Pli cutané persistant
- B. Polyurie
- C. Froideur des extrémités
- D. Polypnée
- E. Troubles de la conscience

57. Les traitements contre-indiqués au cours de l'état de choc cardiogénique sont :

- A. Bêtabloquants
- B. Dérivés nitrés
- C. Diurétiques
- D. Intubation orotrachéale
- E. Angioplastie coronaire en cas de syndrome coronaire Aigu

58. Les traitements du choc cardiogénique sont :

- A. les inhibiteurs calciques
- B. L'oxygénothérapie
- C. La Dopamine
- D. La Noradrénaline
- E. La Dobutamine

59. L'état de choc hémorragique :

- A. Est un choc distributif
- B. Entraîne un défaut d'extraction de l'oxygène
- C. La saturation veineuse en oxygène (SVO₂) est diminuée
- D. Le transport en oxygène est diminué
- E. Entraîne un pincement de la différence artérioveineuse

60. Au cours de la phase sympatho-excitatrice du choc hémorragique ils existent :

- A. Une augmentation de l'activité sympathique afférente
- B. Une vasodilatation splanchnique responsable d'une ischémie mésentérique
- C. Une prédominance de la vasoconstriction veineuse
- D. Une inhibition du système rénine angiotensine aldostérone
- E. Une augmentation de la fréquence cardiaque et de la contractilité myocardique

61. Au cours de la phase sympatho-inhibitrice du choc hémorragique :

- A. Survient pour une réduction de la masse sanguine de 20%
- B. Les systèmes rénine angiotensine aldostérone et sympathique sont activés
- C. La libération d'adrénaline par la médullosurrénale joue un rôle très important
- D. La stimulation des mécanorécepteurs intra-cardiaques entraîne une bradycardie paradoxale caractéristique du choc hémorragique sévère
- E. Les résistances systémiques sont augmentées

62. Les mécanismes de compensation du choc hémorragiques peuvent être altérés par :

- A. Un traitement mal contrôlé par diurétique
- B. Un traitement par digitalique
- C. Un traitement par bêta bloquant
- D. L'anesthésie générale
- E. Un traitement par antagoniste de l'angiotensine II (ARA II)

63. Les mécanismes physiopathologiques rencontrés lors de l'intoxication aux organophosphorés sont :

- A. l'accumulation de l'acétylcholine
- B. la stimulation de l'activité acétylcholinestérasique.
- C. l'hydrolyse de l'acétylcholine en choline et en acide acétique.
- D. la phosphorylation de la neuropathylargetestérase (NTE) par certains organophosphorés.
- E. le franchissement de toutes les barrières biologiques

64. Les antidotes des organophosphorés sont :

- A. Le glucagon
- B. Le méthylsulfate de pralidoxime (PAM-2) : contrathion
- C. La N acétyl cystéine
- D. Le sulfate d'atropine
- E. Le sulfate de protamine

65. Choisissez parmi les propositions suivantes les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique qui peuvent aggraver le pronostic d'un traumatisé crânien grave :

- A. $\text{PaCO}_2 = 38 \text{ mmHg}$
- B. $\text{PaO}_2 = 52 \text{ mmHg}$
- C. $\text{Na}^+ = 128 \text{ mmol/l}$
- D. Température = $38,6^\circ\text{C}$
- E. PAM = 102 mmHG

66. Le néfopam (Acupan) est :

- A. Un antalgique du palier II de la classification de l'O.M.S.
- B. Est contre indiqué en cas d'épilepsie
- C. Plus puissant que le tramadol injectable
- D. Contre-indiqué en cas de glaucome à angle fermé
- E. Il diminue le seuil épileptogène en cas d'association avec les antidépresseurs tricyclique

67. Le recours à la morphine titrée intraveineuse se justifie d'emblée en cas :

- A. De douleurs aiguës intenses avec EVA > 6
- B. D'une douleur modérée insuffisamment calmée par les analgésiques non morphiniques.
- C. De douleur neurologique
- D. De douleur psychologique
- E. De douleur abdominale

68. Le trou anionique est augmenté dans les situations suivantes :

- A- Acidose tubulaire
- B- Diarrhée profuse
- C- Acidose lactique
- D- Acidocétose diabétique
- E- Insuffisance rénale chronique

69. Le trou anionique est normal dans les situations suivantes :

- A- Intoxication à l'acide salicylé (aspirine)
- B- Acidose tubulaire
- C- Diarrhée
- D- Intoxication au méthanol
- E- Intoxication à la metformine

70. les médicaments qui peuvent provoquer une alcalose respiratoire sont :

- A- Salicylate
- B- Progestérone
- C- Agoniste des B adrénergiques
- D- Amiodarone
- E- Inhibiteurs de l'enzyme de conversion

71. Concernant la composition des liquides corporels en eau :

- a- On trouve la majorité de l'eau corporels dans les graisses
- b- Il n'y a pas d'eau dans les os
- c- Le pourcentage d'eau dans le corps augmente proportionnellement avec l'âge
- d- On retrouve plus d'eau dans le liquide intra cellulaire que dans le liquide extracellulaire
- e- Les muscles contiennent 30% du volume total d'eau dans le corps

72. concernant les compartiments liquidiens corporels

- a- Le liquide extracellulaire (LEC) est composé de plasma, de cytosol, de liquide interstitiel, et de lymphe
- b- Le compartiment vasculaire contient moins d'eau que le cytosol
- c- Il n'y a pas de différence de composition en eau entre le intracellulaire (LIC) et le LEC
- d- Il y a des échanges d'eau entre le LIC et le LEC par pression osmotique
- e- On retrouve la plupart de l'eau du corps dans les cellules

73. Dans le liquide extra-cellulaire (LEC) :

- a- On retrouve pratiquement la même composition ionique et la même osmolarité dans le plasma et le liquide interstitiel
- b- On y retrouve du Na⁺, du Cl⁻ et du bicarbonate (HCO₃⁻)
- c- On ne retrouve pas de protéines dans le liquide interstitiel mais dans le plasma
- d- La pression oncotique du plasma est plus élevée que dans le liquide interstitiel
- e- Le plasma est le liquide dans lequel baigne les cellules

74. Parmi les facteurs suivants , ceux qui contribuent aux œdèmes sont :

- A-facteur natriurétique cérébral
- B-Endothéline
- C-Aldostérone
- D-Hormone antidiurétique
- E-Prostaglandine E2

75. Au cours du syndrome de Cocket ou de May –Thurner, les œdèmes sont :

- A- bilatéraux
- B- localisés au membre inférieur gauche
- C- dus à une compression veineuse
- D- dus à une accumulation de fluides dans le tissu adipeux
- E- réversibles après traitement chirurgical

76. La réabsorption tubulaire des bicarbonates :

- A. est maximale dans le néphron distal
- B. concerne 50 % des bicarbonates filtrés
- C. s'accompagne d'une réabsorption de Na^+ et d'une sécrétion d'ions H^+ dans le néphron proximal
- D. s'accompagne d'une réabsorption de K^+ et d'une sécrétion d'ions H^+ dans les cellules intercalaires A
- E. diminue en cas d'acidose

77. Le tampon ammoniacal :

- A. est produit à partir de la glutamine
- B. est d'autant plus actif que le pH plasmatique est bas
- C. est responsable du 1/3 de l'excrétion urinaire acide
- D. excrète les ions H^+ sous forme d'acidité titrable
- E. permet de régénérer des ions bicarbonates au niveau urinaire

78. Les inhibiteurs de la lithogénèse sont

- A- Sodium
- B- Magnésium
- C- Citrate
- D- Urée
- E- Zinc

79. Les facteurs favorisant l'hypercalciurie sont

- A- une alimentation riche en sel
- B- une alimentation riche en protéines
- C- la surconsommation d'agrumes
- D- un apport alimentaire excessif de produits laitiers
- E- Boissons insuffisantes

80. Devant une hématurie associée à une douleur lombaire on évoque :

- A. Une lithiase rénale
- B. Une sténose de l'artère rénale
- C. Une cystite
- D. Une tumeur rénale
- E. Une glomérulonéphrite post infectieuse

81. Devant une hématurie associée à un complément sérique normal on évoque :

- A. Une glomérulonéphrite avec dépôts mésangiaux d'immunoglobuline A
- B. Une vascularite à ANCA
- C. Une cryoglobulinémie
- D. Un syndrome d'Alport
- E. Un syndrome hémolytique et urémique atypique

82. La glomérulonéphrite aiguë post infectieuse est :

- A. Fréquente chez le sujet âgé
- B. Récidivante
- C. Traitée par des corticoïdes
- D. Révélée le plus souvent par une glomérulonéphrite rapidement progressive
- E. Classiquement bénigne

83. Devant une adénopathie cervicale du groupe IIA chez un patient âgé de 15 ans, vous devez éliminer :

- A. Un nodule thyroïdien
- B. Un lymphangiome kystique
- C. Un Kyste du tractus thyroïdial
- D. Un Kyste de la 2ème fente branchiale
- E. Une submandibulite lithiasique

84. Chez une jeune patiente de 35 ans présentant une adénopathie sus claviculaire isolée évoluant depuis 3 mois, les diagnostics à évoquer sont :

- A. Une tuberculose ganglionnaire
- B. Une métastase ganglionnaire d'un cancer du cavum
- C. Une mononucléose infectieuse
- D. Une métastase ganglionnaire d'un cancer du sein
- E. Un adénophlegmon

85. La drépanocytose homozygote peut se compliquer :

- A- d'un syndrome thoracique aiguë
- B- des crises vaso-occlusives
- C- de transformation en leucémie aiguë
- D- d'une aplasie médullaire
- E- de priapisme aiguë

86. Au cours d'une anémie mégalo-blastique non traitée, il est habituel de trouver à l'hémogramme :

- A- Une leucopénie
- B- Une hyperplaquettose
- C- Des polynucléaires neutrophiles hypersegmentés
- D- Des mégalo-blastes
- E- Une anisocytose

87. Devant une anémie mégalo-blastique par carence en vitamine B 12, les examens à demander pour préciser le mécanisme de la carence sont :

- A- Fibroscopie gastrique avec biopsie
- B- Anticorps anti-cellules pariétales
- C- Myélogramme
- D- Anticorps anti-facteur intrinsèque
- E- Test thérapeutique

88. Parmi les états suivants, lesquels peuvent être responsables d'une carence martiale ?

- A- Régime lacté exclusif
- B- Ménométrorragies
- C- Maladie coeliaque
- D- Hématurie microscopique
- E- Hémorroïdes

II- Partie II : CCQCM

Cette partie comprend cas cliniques. Les réponses doivent être inscrites sur la grille réservée aux CCQCM

Cas Clinique 1:

Mme M âgée de 32 ans, tabagique, est adressée par son médecin généraliste pour hyperthyroïdie. Sa sœur est suivie pour une thyroïdite de Hashimoto. La patiente rapporte des palpitations et un amaigrissement récent. L'examen retrouve un goitre homogène visible à distance et une exophtalmie avec un œdème palpébral bilatéral. L'ECG montre une tachycardie sinusale à 120 batt/min. Au bilan thyroïdien, la TSH est à 0,01 mUI/l et la FT4 est à 88 pmol/l (10,6-24 pmol/l). La patiente a été mise sous Thiamazole : 20 mg/j.

1. Les arguments cliniques en faveur de l'origine Basedowienne de cette hyperthyroïdie sont:

- A. L'antécédent familial de thyroïdite de Hashimoto chez la sœur
- B. La tachycardie à 120 batt/min
- C. L'amaigrissement
- D. Le goitre homogène
- E. L'exophtalmie avec un œdème palpébral bilatéral

2. Parmi les facteurs qui peuvent aggraver l'atteinte oculaire de cette patiente, vous retenir:

- A. Le tabagisme
- B. L'antécédent familial de thyroïdite de Hashimoto chez la sœur
- C. Le taux de FT4 supérieur à 3 fois la normale
- D. Le traitement par Thiamazole
- E. L'éventuel passage en hypothyroïdie sous thiamazole

3. Le traitement par thiamazole chez cette patiente :

- A. Agit sur la synthèse des hormones thyroïdiennes
- B. Diminue le taux de FT4 après 10 à 15 jours
- C. Nécessite une surveillance par les anticorps anti-récepteur de TSH
- D. Est contre-indiqué en association aux bêtabloquants
- E. Doit être maintenu à vie

4. Après une semaine, la patiente consulte pour fièvre à 38° avec douleur cervicale, la conduite à tenir doit comporter :

- A. La mise en route urgente d'antibiothérapie
- B. le dosage de FT4
- C. Une échographie cervicale en urgence
- D. La recherche d'agranulocytose
- E. Une NFS en urgence

Cas clinique 2 :

Mr B. âgé de 60 ans est suivi pour un diabète type 2 depuis 15 ans. Il est traité par la metformine 2g/j et la Glimépiride 6 mg/j. Dans ses antécédents on note une lithiase vésiculaire simple sous surveillance.

Lors de son control trimestriel, son examen trouve un IMC à 26 kgm-2 avec une perte du poids de 4 kg sur une année, des réflexes achilléens abolis et une hyperkératose plantaire. Son fond d'œil a objectivé la présence des néovaisseaux.

A la biologie : HbA1c à 9,5%, glycémie à jeun à 13 mmol/l, clairance rénale à 58 ml/mn et une microalbuminurie à 350 mg/24 heures, cholestérol plasmatique à 5 mmol/l, HDL à 1 mmol/l, triglycéridémie à 1,6 mmol/l, LDL à 3,27 mmol/l

5. Mr B. présente :

- A. Un très haut risque cardiovasculaire
- B. Une rétinopathie diabétique proliférante
- C. Une neuropathie diabétique
- D. Une insulino-pénie
- E. Un bilan lipidique correct

6. Pour compléter le bilan de retentissement du diabète chez Mr B. vous réalisez :

- A. Un électromyogramme (EMG)
- B. Une échographie doppler artérielle des troncs supra-aortiques
- C. Un ECBU
- D. Une échographie rénale
- E. Un test au monofilament

7. Pour Mr B. vous préconisez les mesures thérapeutiques suivantes :

- A. L'arrêt de Glimépiride et l'initiation d'une insulinothérapie basale
- B. Garder la metformine à la dose de 2g/j
- C. La prescription d'une statine à forte dose
- D. Une éducation thérapeutique pour prévenir le risque podologique
- E. L'introduction d'un inhibiteur du cotransporteur sodium glucose de type 2

8. Quatre mois après, Mr B est hospitalisé en chirurgie générale pour cholécystite aiguë. Vous recommandez :

- A. La réduction de la dose du metformine en péri-opératoire
- B. Une bonne hydratation
- C. Le maintien de l'insulinothérapie
- D. Opérer Mr B à la fin du programme opératoire
- E. Une perfusion du sérum glucosé 5% à débit constant le jour de l'intervention

Cas clinique 3 :

Madame MA, âgée de 66 ans, hypertendue, consulte pour asthénie, douleurs abdominales et vomissements évoluant depuis 2 jours. Elle a consulté un Rhumatologue, 2 ans auparavant, pour poly arthralgies. Elle a été mise sous prednisolone 50 mg par jour pendant 5 jours. La patiente a repris le même traitement de son propre chef pendant 6 mois. La dernière prise de corticoïdes remonte à 10 jours. A l'examen: poids : 98 Kg (poids antérieur: 82 Kg), TA : 10/6cmHg, pouls : 100 b/mn, érythrose faciale, vergetures pourpres au niveau des 2 flancs. Bilan : Glycémie : 0,4 g/l, urée : 10 mmol/l, créatinine : 120 µmol/l, CRP : 13mg/l, GB : 7770 el/mm³, Na⁺ : 132mmol/l, K⁺ 3,2mmol/l, calcémie : 2,2 mmol/l, Cortisol : 30 ng/ml

9. Chez cette patiente, l'insuffisance surrénalienne aiguë est évoquée devant:

- A. La kaliémie
- B. La calcémie
- C. L'urée
- D. La natrémie
- E. La glycémie

10. Le diagnostic d'insuffisance surrénalienne secondaire à l'arrêt brutal de corticoïdes est probable devant :

- A. La durée de prise de corticoïde
- B. Le type de corticoïde
- C. Le mode d'administration des corticoïdes
- D. La prise de poids
- E. Les vergetures abdominales

11. Le diagnostic positif d'insuffisance surrénalienne chez cette patiente:

- A. Nécessite le dosage de l'ACTH
- B. Nécessite la réalisation d'un test au synacthène
- C. Nécessite un contrôle de la cortisolémie à 8 heure du matin
- D. Nécessite le dosage de la rénine et de l'aldostérone
- E. Est retenu

12. la conduite à tenir chez cette patiente comporte :

- A. Une hospitalisation
- B. Un traitement par Sérum glucosé 30% en intraveineux
- C. Une réhydratation avec supplémentation en K⁺
- D. Hydrocortisone 30 mg
- E. Fludrocortisone

13. après stabilisation de la patiente, l'insuffisance surrénalienne:

- A. Nécessite un traitement par hydrocortisone à vie
- B. Est centrale
- C. Nécessite un traitement par hydrocortisone à la dose de 30 mg/j
- D. Nécessite un contrôle régulier de la cortisolémie à 8h
- E. N'entraîne pas de décompensations aiguës sous hydrocortisone

Cas clinique 4 :

Mr M âgé de 41 ans , tabagique et éthylique , participe à un dépistage. Son examen montre: IMC: 32kg /m²; tour de taille: 102 cm; TA:13/8; loge thyroïdienne libre; pas de xanthomes; pouls régulier à 80 c/mn; ECG: Normal à la biologie : Glycémie: 6.5 mmol/l , TG: 7 mmol/l , CT: 4.5 mmol/l HDL-C: 0,8 mmol/l Protéinurie: 0

14. Ce patient présente:

- A- un diabète sucré
- B- un syndrome métabolique
- C- une HTA
- D- une maladie cardio-vasculaire avérée
- E- une hypertriglyceridemie

15. Sa dyslipidémie est en rapport avec:

- A- l'obésité
- B- l'hypothyroïdie
- C- l'alcool
- D- le tabac
- E- le diabète

16. Ce patient doit réduire l'apport en:

- A- alcool
- B- glucides simples
- C- graisses polyinsaturé insaturées
- D- sodium
- E- acides gras trans

17. En dehors des mesures hygiéno-diététiques, ce patient devra bénéficier de:

- A- inhibiteur de l'enzyme de conversion
- B- statines
- C- fibrates
- D- metformine
- E- anti-coagulants

Cas clinique 5 :

Nourrisson âgé de 10 mois hospitalisé pour crise convulsive généralisée de durée 2 minutes dans un contexte de fièvre. A l'examen : Température à 39°C, Bon état hémodynamique Conscient mais irritable, hypotonie de la nuque et fixité regard Le reste de l'examen est sans particularités.

18. Quelle est votre conduite à tenir immédiate

- A. Hospitalisation
- B. Ponction lombaire (PL)
- C. Scanner cérébral injectée
- D. Electroencéphalogramme (EEG)
- E. Traitement antibiotique IV en urgence

La ponction lombaire a montré un liquide trouble hypertendu avec une protéinorachie à 1,5 g/l, une hypoglycorachie à 0,5 mmole/l, des leucocytes à 450/mm³ à prédominance polynucléaires neutrophiles (80%). A l'examen direct bacille à gram négatif. Le diagnostic d'une méningite bactérienne a été retenu.

19. Quel est l'agent infectieux le plus probable.

- A. *Streptococcus pneumoniae* (Pneumocoque)
- B. *Listeria monocytogène*
- C. *Haemophilus influenzae*
- D. *Neisseria meningitidis* (Méningocoque)
- E. *Streptococcus agalactie* (Streptocoque B)

20. Quelle est votre attitude thérapeutique ?

- A. Pénicilline G
- B. Pénicilline A (Ampicilline)
- C. Céphalosporine de 3^{ème} génération
- D. Vancomycine
- E. Fosfomycine

21. Quels sont les éléments de surveillance ?

- A. Température
- B. Poids
- C. Périmètre crânien
- D. Ponction lombaire à 48-72 heures
- E. Scanner cérébral à 48 heures.

22. Au 5^{ème} jour d'hospitalisation le nourrisson a reconvulsé avec réapparition de la fièvre. Quelle est votre attitude ?

- A. Modifier l'antibiothérapie
- B. Faire une TDM cérébrale
- C. Refaire la ponction lombaire
- D. Faire un Electroencéphalogramme (EEG)
- E. Faire un fond d'œil

Cas clinique 6 :

Un malade âgé de 60 ans, sans antécédents pathologiques, amené par ses parents aux urgences pour perte de la mémoire, une confusion et agitation associée à une fièvre.

L'examen clinique trouve un malade fébrile, SCG 13/15. A la biologie NFS GB :3400/mm³, HB : 13g/dcl plaquettes 120000/mm³ CRP : 30 mg/L

La PL avait montré : Liquide clair, EB : 2000/mm³ (80% lymphocytes), ER : 30/mm³, protéinorachie : 0,8 g/l, glycorachie :3 mmol/l (glycémie : 5 mmol/l), examen direct négatif.

Vous suspectez le diagnostic d'une **méningoencéphalite herpétique**

23. Les éléments en faveur du diagnostic sont

- A. Age
- B. Évolution brutale
- C. Sexe masculin
- D. L'agitation
- E. La perte de mémoire

24. A la ponction lombaire les éléments en faveur du diagnostic sont

- A. Cellularité à 2000/mm³
- B. Prédominance lymphocytaire
- C. Hyperprotéinorachie
- D. La glycorachie
- E. Les éléments rouges

25. Le traitement se base sur

- A. Aciclovir
- B. La corticothérapie
- C. L'hydratation
- D. Les anticonvulsivants
- E. Les sédatifs

26. Au bout de 48h, le patient est devenu calme apyrétique. La durée préconisée est :

- A. 4jours
- B. 7 jours
- C. 10 jours
- D. 14 jours
- E. 21 jours

Cas clinique 7 :

Une femme âgée de 28 ans, enceinte à 20 SA, chez qui le diagnostic d'une infection par le VIH a été fait suite à la survenue d'une pneumocystose pulmonaire

27. Les examens à demander pour évaluer l'évolutivité de l'infection

- A. Western blot
- B. Charge virale
- C. Antigénémie P24
- D. Taux de CD4
- E. ELISA 4^{ème} génération

28. La transmission de l'infection au nouveau-né

- A. Ne survient qu'au moment de l'accouchement
- B. Est inversement corrélée à la charge virale plasmatique
- C. Est possible par l'allaitement
- D. Dépend du taux de CD4
- E. Est réduite par la prescription d'un traitement antirétroviral

29. Le traitement de la pneumocystose chez cette patiente repose sur la molécule suivante :

- A. Aciclovir
- B. Fluconazole
- C. Cotrimoxazole
- D. Amphotéricine B
- E. Doxycycline

30. La prise en charge de cette patiente, en dehors du traitement de la pneumocystose repose sur :

- A. La recherche des autres infections opportunistes
- B. La recherche des autres IST
- C. L'administration immédiate du traitement antirétroviral
- D. La programmation de l'accouchement systématique par césarienne
- E. Le dépistage du ou des partenaires

Cas clinique 8 :

Patiente âgée de 56 ans, diabétique est transférée par le biais du SAMU pour dyspnée associée à une toux productive ramenant des expectorations purulentes évoluant depuis 4 jours dans un contexte de fièvre et de frissons.

A l'examen : température=39,5°C, polypnée à 35 cycles/min avec signes de lutte, SpO₂ = 70% à l'air ambiant, des râles crépitants localisés au niveau de la base droite, FC= 140bpm, TA=80/40 mmHg avec des extrémités froides et des marbrures au niveau des deux genoux (sachant qu'elle a déjà reçu un remplissage vasculaire par 2 litres de sérum physiologique).

Radiographie du thorax : foyer alvéolaire basal droit

Vous retenez le diagnostic d'état de choc septique à point de départ pulmonaire

31. Quelle sera votre conduite à tenir ?

- A. Continuer le remplissage jusqu'à normalisation de la pression artérielle
- B. Introduire la Noradrénaline
- C. Antibiothérapie par Augmentin seul
- D. Intubation orotrachéale
- E. Dobutamine

32. Quels sont les germes à incriminer dans la pneumopathie de ce patient :

- A. *Haemophilus influenzae*
- B. Acinétobacter
- C. Pneumocoque
- D. Légionnelle
- E. *Enterococcus faecalis*

33. Parmi les associations antibiotiques suivantes, laquelle (ou lesquelles) choisissez-vous en première intention :

- A. Oxacilline + gentamicine
- B. Céfotaxime+ gentamicine
- C. Tazocilline+amikacine
- D. Céfotaxime + Lévofoxacine
- E. Oxacilline + ofloxacine

Cas clinique 9 :

Monsieur M, âgé de 55 ans, aux antécédents de diabète et de goutte, consulte aux urgences pour une impotence fonctionnelle du genou droit. A l'anamnèse, vous apprenez que les symptômes évoluent depuis dix jours. Il a pris de l'amoxicilline de son propre chef pendant 3 jours. Le patient vous signale aussi qu'il a eu il y a 15 jours une injection de corticoïdes au niveau de ce même genou pour une gonarthrose débutante. L'examen aux urgences trouve : une température à 37.6°C, une impossibilité de marcher, un genou droit globalement tuméfié chaud à la palpation. La moindre mobilisation passive est extrêmement douloureuse. Vous suspectez une arthrite septique du genou.

34. L'absence de fièvre chez ce patient peut être expliquée par:

- A. L'injection de corticoïdes dans le genou
- B. L'antécédent de goutte
- C. Le diabète
- D. L'automédication par amoxicilline
- E. Il s'agit d'une forme débutante

35. Les 2 diagnostics différentiels à évoquer chez ce patient sont :

- A. Une poussée de gonarthrose
- B. Une poussée polyarthrite rhumatoïde
- C. Une crise de goutte
- D. Une lombosciatique tronquée
- E. Une arthropathie diabétique

Vous trouvez effectivement un épanchement du genou et vous décidez alors de réaliser une ponction du liquide articulaire afin de confirmer le diagnostic d'arthrite septique.

Les résultats de l'analyse du liquide ponctionné sont les suivants :

-aspect : 60ml de liquide trouble

-examen direct à la coloration de Gram : présence de cocci gram positif en chainettes

-examen cytologique : leucocytes= 45000 avec 100% de type polynucléaires altérés, hématies =0, absence de microcristaux

-examen biochimique : Glucose 1.2mmol/l, Protides=98g/l

36. Ces nouvelles données permettent d'affirmer que:

- A. Le taux de glucose est élevé
- B. Le taux de protides est élevé
- C. L'aspect trouble confirme le diagnostic d'arthrite septique
- D. Le caractère altéré des polynucléaires est en faveur du diagnostic d'arthrite septique
- E. La présence de cocci gram positif confirme le diagnostic d'arthrite septique

37. Le diagnostic d'arthrite septique du genou est retenu. La bactérie le plus probablement responsable de cette arthrite septique est :

- A. *Streptococcus pneumoniae*
- B. *Escherichia coli*
- C. *Staphylococcus aureus*
- D. *Neisseria gonorrhoeae*
- E. *Mycobacterium tuberculosis*

Cas clinique 10 :

Un homme de 20 ans après un accident de motocyclette présente une fracture comminutive des deux os de la jambe ouverte type III de Cauchoix, sans lésions vasculaires des axes jambiers.

38. Quels traitements sont justifiés chez ce patient ?

- a. ostéosynthèse par plaque visée.
- b. parage au bloc opératoire avec réalisation d'un fixateur externe.
- c. plâtre ferme cruro-perieux
- d. traction continue trans-calcaneenne.
- e. une antibiothérapie par voie générale

39. L'examen clinique trouve une absence de la flexion dorsale de la cheville. Est considérée comme complication immédiate chez ce patient :

- a. la paralysie du nerf sciatique poplité externe.
- b. la pseudarthrose.
- c. l'ostéite.
- d. l'absence de pouls pédieux.
- e. l'infection du site opératoire.

Le lendemain le patient présente des douleurs type paresthésie non calmées par les antalgiques. A l'examen physique on note une tension importante au niveau de la jambe avec pouls capillaires présent au niveau des orteils.

40. Un syndrome de loge est retenu chez ce patient, ce syndrome :

- a. est spécifique aux fractures ouvertes de jambes.
- b. est toujours associé à une disparition des pouls périphériques.
- c. est traité par aponévrotomie en urgence.
- d. peut-être dû à un hématome dans une loge fermée.
- e. peut évoluer vers le syndrome de Volkmann s'il n'est pas pris en charge à temps

Cas clinique 11 :

Vous assurez une garde au service de Rhumatologie. Vous êtes appelé à intervenir auprès d'un patient de 40 ans, diabétique, hospitalisé pour arthrite septique- jusque-là stable qui s'est effondré sans prodromes. Le Patient était inconscient, Présentant une respiration Agonale.

41. Le diagnostic d'arrêt cardio-respiratoire est posé quand:

- A. Le patient est inconscient et ne respire pas.
- B. Le patient est inconscient avec une respiration anormale, agonale.
- C. Le patient est inconscient et respire normalement.
- D. Le patient est inconscient avec mydriase bilatérale.
- E. Le patient est inconscient avec bradycardie.

42. A quelle fréquence doit-on réaliser les compressions thoraciques lors d'une réanimation cardio-pulmonaire?

- A. 40 compressions/min.
- B. 50 compressions/min.
- C. 100 à 120 compressions/min.
- D. 150 compressions/min.
- E. Cela dépend du nombre de secouristes.

43. En cas de fibrillation ventriculaire (FV), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le choc électrique externe doit toujours être délivré avec une énergie maximale.
- B. La FV à petites mailles réagit mieux à la défibrillation que la FV à grandes mailles.
- C. L'administration d'adrénaline est contre-indiquée compte tenu de son caractère arythmogène.
- D. La défibrillation est immédiatement suivie par des compressions thoraciques.
- E. La défibrillation doit être immédiatement suivie par la recherche d'un pouls.

44. Le pronostic neurologique après arrêt cardio respiratoire est d'autant meilleur que :

- A. Le rythme constaté est une asystolie.
- B. Le rythme constaté est une fibrillation ventriculaire.
- C. La durée de la réanimation cardio-pulmonaire est courte.
- D. Le patient est hypotherme.
- E. La défibrillation est précoce.

Cas clinique 12 :

Mr RG 82 ans, sans antécédents médicaux notables est une victime d'un braquage avec un coup de bâton crânien. A l'arrivée de l'équipe de SAMU, le patient était par terre n'ouvre pas les yeux à la stimulation douloureuse émet des sons incompréhensibles et fléchit les membres supérieurs après stimulation douloureuse.

45. Le score de Glasgow chez ce patient est de :

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

46. Quels signes de gravité à rechercher chez ce patient ?

- A. Notion de convulsion
- B. Plaie du scalp
- C. Pupilles en intermédiaires
- D. Anisocorie
- E. Absence du réflexe photomoteur

47. Choisissez parmi les propositions suivantes les principes de la prise en charge pré hospitalière de ce patient :

- A. Induction en séquence rapide
- B. Intubation orotrachéale
- C. Hypotension permissive
- D. Mettre une minerve cervicale
- E. Ventilation au masque facial

48. Choisissez parmi les propositions suivantes les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique qui peuvent aggraver le pronostic de ce patient :

- A. $\text{PaCO}_2 = 38 \text{ mmHg}$
- B. $\text{PaO}_2 = 52 \text{ mmHg}$
- C. $\text{Na}^+ = 128 \text{ mmol/l}$
- D. Température = $38,6^\circ\text{C}$
- E. PAS = 102 mmHG

Arrivé à l'hôpital le patient avait une anisocorie avec mydriase à droite, une TDM cérébrale et du rachis cervical lui a été réalisé a montré :



49. Que proposez-vous comme traitement ?

- A. Phynétoïne pour prévention des convulsions
- B. au bloc opératoire pour contusectomie
- C. Sérum salé hypertonique 40cc/30min
- D. Mannitol 0,1g/Kg
- E. Lutter contre les ACSOS

Cas clinique 12 :

Une patiente âgée de 75 ans suivie pour une insuffisance cardiaque traitée par furosémide, digitaline et beta bloqueurs et pour une ostéoporose traitée par calcium et vitamine D présente pour une asthénie, une faiblesse musculaire, des palpitations et une constipation installée depuis une semaine. A l'examen clinique : PA : 100/50 mmHg, pli cutané persistant, auscultation cardio-pulmonaire normale et un tympanisme abdominal. Biologie : créatinine sérique : 50 μ mol/l, natrémie : 135mmol/l, Kaliémie : 2,4mmol/l, chlorémie : 85mmol/l, GDS artériel : PH : 7,50, bicarbonatémie : 30mmol/l.

50. Les critères de gravité de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- A. L'antécédent d'une insuffisance cardiaque
- B. La prise de digitaline
- C. La présence d'une alcalose métabolique
- D. La kaliémie à 2,4 mmol/l
- E. L'âge à 75 ans

51. Les signes électrocardiographiques à rechercher chez cette patiente sont :

- A. Une arythmie par fibrillation auriculaire
- B. Des extra systoles supra ventriculaires
- C. La disparition de l'onde P
- D. L'onde U
- E. Le sous décalage du segment PQ

52. Les causes possibles de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- A. Prise du furosémide
- B. Des vomissements
- C. Intoxication aux digitaliques
- D. Prise de bêta bloqueur
- E. La prise de calcium au long cours

53. Les examens complémentaires à demander à la recherche d'une étiologie de l'hypokaliémie chez cette patiente sont :

- A. Kaliurèse de 24 heures
- B. Aldostéronémie
- C. Activité rénine plasmatique
- D. Chlore urinaire
- E. Echographie doppler des artères rénale

Cas clinique 13 :

Un patient de 64 ans, obèse, diabétique, suivi pour goutte, consulte aux urgences pour une crise de colique néphrétique droite.

A l'examen physique : patient apyrétique, douleur à la palpation de la fosse lombaire droite qui reste souple, le reste de l'examen est sans particularités.

La radiographie de l'AUSP est sans anomalies. L'échographie rénale montre un calcul pyélique obstructif de 1,8 cm.

54. La prise en charge en urgence pour ce patient comporte :

- a. La prescription d'un AINS
- b. Le drainage des cavités excrétrices par une sonde urétérale
- c. Une hyper diurèse
- d. La réalisation d'un bilan étiologique de sa maladie lithiasique
- e. Une alcalinisation des urines

Le patient a été exploré à distance par un uroscanner qui a conclu à un calcul pyélique droit de 1,5 cm obstructif ayant une densité de 350 UH.

55. Quelle est la nature présumée de ce calcul ?

- a. Calcul d'acide urique
- b. Calcul d'infection
- c. Calcul cystinique
- d. Calcul oxalocalcique
- e. Calcul phosphocalcique

56. Le (les) traitement(s) chirurgical(aux) que vous indiquez en première intention pour ce calcul est(sont) :

- a. Une néphrolithotomie percutanée
- b. Une lithotritie extracorporelle sous repérage échographique
- c. Une alcalinisation des urines
- d. Une pyélolithotomie
- e. Une urétéro-rénoscopie souple

57. Quelles mesures diététiques préconisez-vous pour ce patient ?

- a. Diurèse de 2 litres / jour
- b. Une alcalinisation des urines
- c. Un régime pauvre en purines
- d. Un régime pauvre en calcium
- e. Limiter la prise de sucres rapides

Cas clinique 14 :

Un patient de 63 ans, consulte pour des troubles urinaires du bas appareil urinaire. Pas d'antécédents pathologiques particuliers.

A l'examen clinique : prostate indurée, nodule du lobe gauche de 5mm respectant parfaitement les contours de la glande. A la biologie : taux de PSA à 12 ng/ml

58. Devant la prostate suspecte de malignité cliniquement et biologiquement, quel examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic de cancer de la prostate ?

- a. Dosage des phosphatases acides
- b. Biopsie prostatique
- c. Examen cytologique des sécrétions recueillis après massage prostatique
- d. Dosage du PCA3
- e. Examen cytologique des urines

Le diagnostic d'un adénocarcinome prostatique score 7 (4+3) de Gleason du lobe gauche a été retenu.

59. Parmi ces examens, lequel (lesquels) demandez-vous pour le bilan d'extension ?

- a. Scintigraphie osseuse
- b. Tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne
- c. TEP scanner
- d. Tomodensitométrie cérébrale
- e. Echographie endorectale

60. Après le bilan d'extension le cancer de la prostate a été classé cT3b N0 M0. Parmi les options thérapeutiques suivantes lesquelles peuvent être indiqués ?

- a. Prostatectomie radicale associée à un curage ganglionnaire ilio-obturateur
- b. Curiethérapie
- c. Surveillance active
- d. Radiothérapie externe associée à une hormonothérapie de six mois
- e. Suppression androgénique médicamenteuse (hormonothérapie)

61. Les examens à demander au cours du suivi post-thérapeutique chez ce patient sont :

- a. Dosage de la testostéronémie
- b. Examen clinique complet
- c. Une IRM pelvienne
- d. Dosage du taux de PSA
- e. Une échographie endorectale

Cas clinique 15 :

Patient âgé de 55 ans, sans antécédents pathologiques notables consulte pour un purpura vasculaire des jambes évoluant depuis 3j. À l'interrogatoire, il rapporte un amaigrissement non chiffré avec asthénie et arthralgies inflammatoires évoluant depuis 1 mois. À l'examen il était en bon état hémodynamique, T°= 37,8°C. Une BU a été pratiqué montrant une PU= ++

62. Devant ce tableau vous évoquez :

- A. Une endocardite d'osler
- B. Un purpura rhumatoïde
- C. Une polyangéite microscopique
- D. Une GPA
- E. Une ACG

63. Durant son hospitalisation, le patient présente une rougeur oculaire avec épistaxis. L'examen ophtalmologique met en évidence une sclérite diffuse et l'examen ORL montre une muqueuse inflammatoire croûteuse. Vous évoquez :

- A. Une endocardite d'osler
- B. Un purpura rhumatoïde
- C. Une polyangéite microscopique
- D. Une GPA
- E. Une ACG

64. Les examens complémentaires à demander :

- A. Biopsie des artères temporales
- B. Une ETO
- C. Une biopsie cutanée
- D. Les ANCA
- E. Dosage des IgA

Cas clinique 16 :

Patiente âgée de 32 ans aux antécédents de lupus érythémateux systémique depuis un an sous plaquénil, consulte pour une asthénie, amaigrissement, vertiges depuis 2 semaines. A l'examen, elle présente un subictère conjonctival avec une flèche splénique à 14cm. Des adénopathies cervicales, axillaires et inguinales entre 1 à 2 cm fermes et indolores. Le reste de l'examen était par ailleurs sans anomalies

65. A ce stade il faut évoquer :

- A. Une tuberculose ganglionnaire
- B. Une poussée lupique
- C. Une maladie des griffes du chat
- D. Un lymphome non Hodgkinien
- E. Une sarcoidose

Au bilan, on trouve : NFS : Hb= 8g/dl ; VGM= 105fl ; plaquettes : 250 000 éléments/ mm³ ; GB= 3200 ; PNN= 2000 ; Ly= 1000 ; Réticulocytes= 200 000

66. Vous évoquez à présent :

- A. Une tuberculose ganglionnaire
- B. Une poussée lupique
- C. Une maladie des griffes du chat
- D. Un lymphome non Hodgkinien
- E. Une sarcoidose

67. Les examens complémentaires suivants vous permettent d'étayer votre diagnostic

- A. Complément
- B. Test de Coombs Direct
- C. Biopsie ganglionnaire
- D. Calcémie
- E. Enzyme de conversion

Cas clinique 17:

Une patiente âgée de 35ans, G3P3, est admise pour un saignement gynécologique abondant La NFS a montré un taux d'Hb à 5g/dl avec des signes d'intolérance. Une transfusion de globules rouges est indiquée.

68. Quels sont les examens immuno-hématologiques indiqués au laboratoire dans le cadre du bilan pré-transfusionnel:

- A. Groupage sanguine ABO-RhD
- B. Phénotypage Rhésus-Kell
- C. Phénotypage élargi
- D. Recherche d'anticorps irréguliers
- E. Test de Coombs Direct

69. La patiente est de groupe AB positif C Positif c positif E Négatif e positif K Négatif. Lesquels des CGRs suivants peuvent être transfusés :

- A. O positif C + c + E+ e + K nég
- B. A positif Cnég c+Enég e+Knég
- C. B positif C+cnég Enég e+Knég
- D. AB positif C+ c+ E+ e+ K+
- E. O positif Cnég c+ Enég e+ K+

Au cours de la transfusion la patiente a présenté un bronchospasme un malaise avec une chute de la tension.et une tachycardie La temperature était de 37.2°C.

70. Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu?

- A. Une réaction frissons hyperthermie
- B. Une réaction de greffon contre l'hôte
- C. Un choc endotoxinique
- D. Une réaction allergique sévère
- E. Un TRALI

71. Comment évaluez-vous la gravité de cet accident:

- A. Grade 1
- B. Grade 2
- C. Grade 3
- D. Grade 4

72. Quelle transformation de produit sanguin est indiquée afin d'éviter une récurrence de cette réaction:

- A. Réduction de volume
- B. Filtration
- C. Irradiation
- D. Lavage
- E. Cryoconservation